

GUÍA DE APLICACIÓN CLÍNICA — Técnica S.T.O.P.

Herramienta de pausa consciente · Para uso del terapeuta en sesión

La técnica S.T.O.P. interrumpe el piloto automático emocional o cognitivo en el momento en que se detecta activación. Sus cuatro pasos permiten al paciente pasar de la reacción automática a la respuesta consciente en menos de dos minutos.

Indicaciones: Rumiación · Impulsos reactivos · Escalada emocional · Craving · Conflictos interpersonales · Estrés agudo situacional

PROTOCOLO PASO A PASO

S STOP

Para

- «*Detente justo donde estás. No hagas nada todavía.*»
- Interrumpir físicamente la actividad o el pensamiento en curso.
 - Señal interna: reconocer activación emocional o cognitiva significativa.
 - **Objetivo:** romper el automatismo reactivo.

T TAKE A BREATH

Respira

- «*Toma una respiración consciente. Nota cómo entra el aire y cómo sale.*»
- Respiración profunda y lenta; atención al movimiento del abdomen.
 - Opcional: técnica 4-4-4 (inhala · retén · exhala, 4 seg cada fase).
 - **Objetivo:** activar el sistema nervioso parasimpático y reducir cortisol/adrenalina.

O OBSERVE

Observa

«*¿Qué está pasando dentro de ti ahora mismo? Sin juzgarlo, sin cambiarlo.*»

Canal	Preguntas guía
Cuerpo	¿Dónde noto tensión? ¿Qué sensaciones físicas hay?
Emociones	¿Qué emoción está presente? ¿Intensidad (0-10)?
Pensamientos	¿Qué dice mi mente? ¿Son hechos o interpretaciones?

Postura de testigo imparcial: observar sin identificarse. Nombrar la emoción («noto que hay ansiedad»). **Objetivo:** distancia metacognitiva y defusión cognitiva.

P PROCEED

Continúa con conciencia

- «*¿Qué quieres hacer ahora? No la reacción automática — lo que tú eliges.*»
- Retomar la actividad con mayor conciencia o elegir una acción deliberada.
 - «*¿Qué haría la persona que quiero ser en este momento?*» (enlace ACT con valores).
 - **Objetivo:** acción consciente frente a reacción automática.

P1 No puede parar — activación demasiado alta

Por qué ocurre: Con activación intensa el córtex prefrontal está inhibido y el paciente no puede «decidir parar».

Qué hacer:

- Añadir ancla física previa: «Pon los dos pies en el suelo, nota el peso. Ahora sí — para.»
- Usar una señal física externa como disparador (ej. mano en el pecho).
- Entrenar la técnica en momentos de baja activación, no en crisis.

P2 La respiración genera más ansiedad

Por qué ocurre: Frecuente en pánico o hipocondría: dirigir atención a la respiración puede disparar más activación.

Qué hacer:

- Redirigir la atención: «Solo observa que estás respirando, sin cambiar nada.»
- Sustituir por pausa sensorial externa: notar la temperatura de la mesa durante 3 segundos.
- Abreviar el paso T a una simple pausa de 2 segundos.

P3 Se pierde en los pensamientos en lugar de observarlos

Por qué ocurre: La instrucción de «observar la mente» puede convertirse en déclencheur de más rumiación (especialmente en depresión o TAG).

Qué hacer:

- Defusión cognitiva ACT: «Nótalo desde fuera. ¿Qué dice? No si es verdad — solo qué dice.»
- Limitar a 5 segundos: «Una palabra o frase es suficiente.»
- Anclar al cuerpo si la mente se dispersa: «¿Dónde sientes la emoción físicamente?»
- Fórmula de nombrado: «En lugar de 'estoy ansioso', prueba 'noto que hay ansiedad'.»

P4 El paso P siempre termina en la misma respuesta automática

Por qué ocurre: El hábito conductual es tan fuerte que vuelve a la respuesta automática aunque haya completado los cuatro pasos.

Qué hacer:

- Trabajar el paso P explícitamente en sesión, en frío: listar opciones antes de que ocurra la situación.
- Conectar con valores: «¿Qué haría la versión de ti que actúa desde lo que más te importa?»
- Introducir micro-demora conductual: «Solo espera 2 minutos antes de actuar.»

P5 Lo hace en sesión pero no lo recuerda en el momento real

Por qué ocurre: Bajo alta activación el acceso al recuerdo procedimental se bloquea; la técnica aún no está automatizada.

Qué hacer:

- Crear una tarjeta física (o fondo de pantalla) con las cuatro letras y una frase por paso.
- Establecer disparador corporal personalizado: la primera señal de activación = inicio del STOP.
- Practicar a diario en situaciones de baja intensidad (atasco, cola, aburrimiento).

P6 Le parece demasiado simple o no se cree que funcione

Por qué ocurre: Pacientes con alta capacidad intelectual o experiencias previas negativas pueden desestimar la técnica.

Qué hacer:

- Explicar el mecanismo: la activación inhibe el córtex prefrontal; parar y observar lo reactiva.
- Ofrecerla como experimento: «No te pido que creas que funciona. Pruébala 5 veces y cuéntame qué observas.»
- Normalizar efecto acumulativo: «La primera vez cambia poco. La décima vez, sí.»

RESUMEN RÁPIDO DE ADAPTACIONES

Dificultad	Adaptación clave
No puede parar	Ancla física previa + entrenar en calma
Respiración genera ansiedad	Observar sin cambiar + sustituir por pausa táctil
Se pierde en pensamientos	Defusión ACT + anclar al cuerpo + límite de tiempo
Siempre termina igual en P	Opciones en frío + conectar con valores
No lo recuerda en el momento	Tarjeta física + disparador corporal personalizado
No se cree que funcione	Explicación neurofisiológica + enfoque experimental